

AGITACIÓN PSICOMOTRIZ EN URGENCIAS

Antonio Serrano García

INTRODUCCIÓN

La agitación psicomotriz es un síndrome que se caracteriza por un marcado incremento de la actividad motora, generalmente se acompaña de:

- **Alteraciones afectivas** como la ansiedad, irritabilidad, euforia y otros
- **Alteraciones del pensamiento** como la desinhibición, incoherencia y otros.

La agitación psicomotriz es una circunstancia relativamente frecuente en los Servicios de Urgencias. Constituye un proceso que requiere atención inmediata puesto que se pone en riesgo tanto la seguridad del propio paciente como la del equipo sanitario que le atiende, debido a la conducta de este puede ser desproporcionada, impulsiva o negligente. Se debe de intentar diferenciar claramente la agitación de la violencia, debido a que la mayoría de los pacientes agitados no son violentos y la mayoría de las actitudes violentas no tienen una clínica/cuadro médico que las justifique. La agitación psicomotriz puede ser de causa: psiquiátrica, orgánica o mixta.

Agitación orgánica

La causa orgánica es lo primero que hay que descartar, supone un riesgo vital para el paciente, sospechamos de causa orgánica cuando el inicio del cuadro es agudo o subagudo en un paciente sin antecedentes psiquiátricos, con episodios fluctuantes, se caracteriza por alteración fluctuante del nivel de consciencia, inatención, desorientación temporoespacial, confusión mental y discurso incoherente. Debemos de diferenciarlo del delirium.

Las pruebas que debemos de realizar en urgencias para descartar organicidad son:

- **Hemograma, bioquímica, coagulación, sistemático y sedimento de orina con tóxicos en orina** (solicitar autorización verbal o escrita del paciente/familiar/acompañante y escribirla en HCL).
- **TAC craneal, Punción lumbar** si fiebre y/o clínica neurológica.

Las principales **causas orgánicas** de agitación orgánica son:

- **Tóxicas:** drogas, alcohol, fármacos (antiparkinsoniano, anticolinérgicos, digitálicos, corticoides, otros),
- **Metabólicas:** encefalopatía hepática, hipoglucemia, uremia, enfermedades endocrinas, hipoxia, hipercapnia, fiebre y alteraciones hidroelectrolíticas: hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia.
- **Neurológicas:** neoplasias, crisis epilépticas, infecciones del sistema nervioso, encefalopatía hipertensiva, ACV, TCE...

Agitación psiquiátrica

No existe alteraciones del nivel de consciencia, descartada la parte orgánica (examen físico y pruebas complementarias), se debe de buscar antecedentes de enfermedades psiquiátricas cuyas manifestaciones serán las propias de cada una desde: alucinaciones auditivas, alteración de la afectividad, ideación delirante, agresividad u hostilidad, alteraciones en el discurso...Las principales **causas de agitación psiquiátrica** son:

- **Trastornos afectivos:** episodio maníaco, episodio de depresión...
- **Trastornos psicóticos:** trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno delirante...
- **Otras causas:** crisis de ansiedad, trastorno de la personalidad, alteración de conducta en pacientes con discapacidad intelectual.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico inicial

Independientemente del origen de la agitación es preciso constatar su existencia y controlarla con objeto de poder llevar a cabo con posterioridad un diagnóstico etiológico y un tratamiento adecuado.

Es preciso distinguir:

- **Agitación leve/moderada:** El paciente se muestra inquieto, nervioso, enfadado o demandante, pero es capaz de entablar una conversación y no se objetiva un riesgo de auto o heteroagresividad inmediato.
- **Agitación grave:** El paciente es incapaz por su estado mental de entablar una conversación o se observa riesgo de auto o heteroagresividad inmediato.

Diagnóstico etiológico

Son múltiples las causas que pueden motivar un estado de agitación en un paciente. Este diagnóstico etiológico sólo puede llevarse a cabo en casos de agitación leve/moderada o cuando la agitación grave haya sido controlada.

Posibles causas de agitación psicomotriz

- Delirium
- Consumo de sustancias
- Abstinencia de sustancias
- Disconformidad con el trato recibido
- Crisis de pánico
- Trastornos de Personalidad Límite/Antisocial
- Episodios psicóticos
- Agitación secundaria a enfermedad somática (encefalitis, IAM, hipoglucemia, demencia, etc...)
- Otras causas

Para realizar un diagnóstico etiológico debe realizarse una anamnesis y examen físico cuidadoso del paciente en la que se establezca si el cuadro de agitación responde a alguna motivación identificable (ambiental) o por el contrario responde a un proceso somático o psicopatológico. En la exploración debe incluirse la evaluación de la consciencia, la orientación, el contenido del pensamiento (ideación delirante), el curso del pensamiento, la sensoropercepción (alucinaciones), el estado de ánimo (euforia, disforia) y el riesgo de auto o heteroagresividad.

Pruebas complementarias

- Constantes vitales: temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, glucemia.
- Hemograma, bioquímica, coagulación, sistemático y sedimento de orina con tóxicos.
- TAC Craneal
- Punción lumbar, si fiebre y/o clínica neurológica.
- Electrocardiograma.
- Alcoholemia si sospecha de ingesta de alcohol, solicitar autorización.

TRATAMIENTO

- Medidas generales: constantes vitales, glucemia, SatO₂.
- Seguridad del personal sanitario y de su entorno: familiares, acompañantes y del mismo paciente.
- Sujeción mecánica si fuera necesario, según protocolo del centro.
- Si no colabora: avisar a seguridad y/o fuerzas del orden: Policía local o nacional si fuera necesario.
- Sedación si persiste agresividad, usar fármacos: ver tabla

Lo primero que debe tenerse en cuenta ante un paciente agitado es asegurar la seguridad del personal sanitario que va a atenderle y de todas las personas que se encuentren en su entorno. De esta manera puede ser necesario solicitar la colaboración del personal de seguridad del centro o incluso, en casos extremos, de las fuerzas de orden público.

En casos de agitación grave puede ser necesaria la contención mecánica del paciente. Ésta deberá llevarse a cabo en todo caso por personal debidamente entrenado y bajo supervisión médica. Este tipo de contención requiere un protocolo estricto que debe estar desarrollado en cada centro sanitario, debe usarse sólo en caso de riesgo inmediato de auto o heteroagresividad, debe supervisarse de forma frecuente (cada 15 minutos por personal de enfermería y cada hora por personal médico) y no debe prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. En caso de contención prolongada (más de 24 horas) se recomienda administrar al paciente heparina subcutánea para minimizar el riesgo de tromboembolismo.

Puede ser necesario administrar fármacos para controlar la agitación. En muchos casos no ha sido posible establecer en el momento de su administración un diagnóstico etiológico. En la tabla se dan algunas pautas en base a diagnósticos de sospecha o a circunstancias clínicas. Una vez controlada la agitación inicial debe procederse a realizar un diagnóstico etiológico preciso.

Fármacos en la agitación psicomotriz

SOSPECHA CLÍNICA	PAUTA DE AGITACIÓN
Paciente mayor de 65 años	• Haloperidol 1/2 ampolla IM. Repetir en 30 min si no cede, máximo 20mg/día. (Contraindicadas benzodicepinas).
Intoxicación etílica	• Tiapríde 1 ampolla IM. Valorar añadir Diazepam (10 mg IM).
Abstinencia de opiáceos	• Clorazepato 20 mg IM. Valorar repetir en 30 minutos.
Crisis de pánico	• Lorazepam 1 mg sublingual. Repetir en 20 minutos si no cede. Si persiste o hay riesgo de tetania por alcalosis respiratoria usar Diazepam 10 mg IV.
Agitación secundaria a enfermedad médica	• Tratamiento etiológico de la causa. Si agitación severa Haloperidol ½ ampolla IM. Repetir en 30 min si precisa.
Agitación por episodio psicótico	• Haloperidol 1 ampolla IM + Clorazepato 50 mg IM (si hay angustia severa). • Haloperidol 1 ampolla IM + Levomepromacina 1 ampolla IM (si existe clínica psicótica intensa).
Trastorno de la personalidad	• Olanzapina (Zyprexa amp 10mg) 1 ampolla IM.
Disconformidad con el trato recibido o ansiedad leve	• Técnicas de tranquilización de verbal. Si persiste o progresa puede ofrecerse lorazepam 1 mg sublingual.

IMPORTANTE

- Ante un paciente agitado lo primero es asegurar la propia seguridad

BIBLIOGRAFÍA

- Juan Manuel Téllez Lapeira (último), Alejandro Villena Ferrer, Susana Morena Rayo, Pablo Pascual Pascual, Carmen López García. Guía clínica de El paciente agitado. Disponible en: <http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-agitado/>
- https://www.fundacionmanantial.org/ssm_area_3/programas/guias/guia_contencion.pdf
- <http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20temas%20de%20Urgencia/17.Psiquiatricas/El%20paciente%20agitado.pdf>